T9 Resumen

Daños derivados del trabajo

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 3-20

🌍 Introducción

pág. 3

- Según la OIT, cada año hay **120 millones de accidentes** laborales en el mundo, con poca difusión pública.
- El trabajo puede afectar a la salud **para bien o para mal**: con peligros, se resiente la salud física y mental; sin ellos y con implicación, mejoran la satisfacción y el bienestar.
- **Daños derivados del trabajo** `LPRL art. 4`: enfermedades, patologías o lesiones sufridas **con motivo u ocasión del trabajo**.
- Hay que evaluar **todos** los riesgos: accidentes, enfermedades y también **insatisfacción, fatiga, estrés y envejecimiento prematuro**.
- Las buenas políticas incluyen la **promoción de la salud**: los trabajadores son un recurso clave.

🚑 El accidente de trabajo

págs. 4–7

Se distingue de otras agresiones por la **«dureza»** de la agresión y la **velocidad** con que produce el daño:

😕 Malestar

Insatisfacción o daños inespecíficos, sin lesión demostrable.

😷 Enfermedad profesional

Agresiones **repetidas** en el tiempo: silicosis, saturnismo, sordera…

💥 Accidente

Una **sola** agresión con lesión leve, grave o mortal.

Los accidentes son el indicador **más inmediato y evidente** de malas condiciones, y combatirlos es el **primer paso** de toda actividad preventiva.

> 🔑 **Definición legal (LGSS art. 156, RDLeg 8/2015)**
> Toda **lesión corporal** que el trabajador sufra **con ocasión o por consecuencia** del trabajo que ejecute **por cuenta ajena**.

- **Lesión corporal**: daño por herida, golpe o **enfermedad**, física o psíquica, aunque aparezca después.
- **Por cuenta ajena**: excluye al autónomo (con excepciones).
- **Con ocasión** (efecto inmediato) **o por consecuencia** (efecto diferido). Tiene que haber **nexo causal** con el trabajo: si algo lo rompe, deja de ser accidente de trabajo.

También son accidente de trabajo

a. Al ir o volver del trabajo: **in itinere** (del latín *iter*, camino).
b. Por desempeñar **cargos sindicales** electivos, y al ir o volver de ellos.
c. En tareas **distintas a su categoría**, por orden del empresario o espontáneamente en interés de la empresa.
d. En actos de **salvamento** conectados con el trabajo.
e. **Enfermedades comunes** que se prueben causadas **exclusivamente** por el trabajo.
f. **Enfermedades o defectos previos** agravados por la lesión del accidente.

g. Consecuencias modificadas por enfermedades **intercurrentes**.

El concepto técnico (preventivo)

Un **suceso anormal**, no querido ni deseado, que se presenta de forma **brusca e inesperada**, normalmente **evitable**, que interrumpe el trabajo y **puede** causar lesiones.

Por qué hay tantos accidentes: desconocer los riesgos · sensación de invulnerabilidad · no conocer sus consecuencias · cultura que los acepta como normales · falta de cultura preventiva · sin sistema de gestión de la prevención.

📁 Tipos de accidentes

págs. 7–8

⚠️ Incidente

Suceso **sin daño a la salud** (puede dañar la propiedad) que, variando un poco las circunstancias, sería un accidente. Son **«reveladores de riesgos»**.

🩹 Sin baja

Pinchazos, cortes, golpes. Hay que analizarlos y **registrarlos**.

🛏️ Con baja

Ausencia de **al menos un día**, sin contar el del accidente. Leves, graves o mortales.

> ⚠️ **Ojo en el test**
> El propósito de investigar un accidente **no es buscar culpables**, sino descubrir las **causas reales** para corregirlas. Si no, se ocultan.

🔺 Accidentes e incidentes: proporciones

págs. 8–10

Frank E. Bird (finales de los 70)

1.753.498 accidentes analizados (más de 3 millones de horas-hombre). Por cada **lesión grave**:

- **9,8** lesiones menores
- **30,2** accidentes con daño a la propiedad

Incluyó **4.000 horas** de entrevistas confidenciales sobre incidentes.

Tye y Pearson (1974/1975)

Casi un millón de accidentes en la industria británica:

- **1** fatal o grave
- **3** leves (baja de al menos 3 días)
- **50** con primeros auxilios
- **80** con daños a la propiedad
- **400** incidentes sin daños

Hay muchos más incidentes que daños: es un error centrarse solo en los sucesos graves. Un resbalón en una mancha de aceite puede dejarte **ileso**, **dañar la ropa**, **romperte un brazo** o **matarte**. El control eficaz se centra en la **causa**, no en el resultado.

La LPRL impone un **modelo activo** (planificar, evaluar, controlar) que va más allá del cumplimiento formal de la antigua OGSHT, y pide además **mejorar los modelos reactivos**.

💸 Los costes

págs. 10–13

Se estiman en **20.000 millones de euros** al año las indemnizaciones por accidentes y enfermedades, sin contar los costes indirectos. El coste **humano** ya sería razón suficiente para evitarlos.

📒 Directos

Los que aparecen **de forma clara en la contabilidad**:

- Pólizas de seguros de AT y EP
- Indemnizaciones
- Gastos sanitarios
- Sanciones y recargos
- Abogados y asesorías

🌫️ Indirectos

No aparecen en la contabilidad, pero la dañan:

- Pérdidas productivas
- Pérdidas de tiempo
- Pérdidas de mercado
- Pérdidas de equipamiento
- Pérdidas materiales

> ⚠️ **Ojo en el test**
> Los indirectos son **muy difíciles de evaluar** y **pueden superar a los directos**. Métodos de cálculo: **Heinrich** y **Simonds**.

😷 La enfermedad profesional

`págs. 13–17`

> 🔑 **Definición legal (LGSS art. 157)**
> La contraída **a consecuencia del trabajo por cuenta ajena** en las actividades del **cuadro** reglamentario, y causada por los **elementos o sustancias** que el cuadro indica para cada enfermedad.

Sus tres elementos

1. **Trabajo por cuenta ajena** (excluye al autónomo, con excepciones).
2. En una **actividad del cuadro**. Si no está, puede ser **accidente de trabajo**, pero no enfermedad profesional.
3. Por una **sustancia o elemento del cuadro** (`RD 1299/2006`).

Enfermedad profesional frente a accidente

🤝 En qué se parecen

En el **contacto** entre la persona y el agente: el nexo causal.

⏳ En qué se diferencian

En la **duración del contacto**: casi instantánea en el accidente, **prolongada** en la enfermedad (repetitiva o continuada), hasta superar el límite de tolerancia.

- Sus efectos suelen ser **irreversibles**: no hay que esperar a los síntomas.
- Una **intoxicación aguda** por sobreexposición es un **accidente**, no una enfermedad profesional.
- Es un concepto **más fijo** que el de accidente: la causalidad es más estricta (no hay «ocasión»).
- Para incluir enfermedades nuevas en el cuadro es **preceptivo el informe del Ministerio de Sanidad**.
- El empresario garantiza la **vigilancia periódica de la salud** según los riesgos `LPRL art. 22` .

Factores que la determinan

Hay **valores máximos tolerados** para muchos riesgos físicos y químicos. Se fijan para una **población normal**, una **jornada normal** y una **vida laboral media**, así que hay que mirar a cada persona, y ponerlos en duda si hay varias agresiones a la vez. Disciplinas: la **higiene industrial** (prevenir las EP actuando sobre el ambiente) y la **medicina del trabajo** (promoción, curación y rehabilitación).

🧠 Otros daños a la salud

pág. 17–18

- Limitarse a accidentes y enfermedades sería ver la salud como mera ausencia de daño, solo una parte de la definición de la OMS.
- El concepto legal de EP **no recoge todas** las que afectan a la salud.
- **Enfermedad derivada del trabajo**: deterioro por una **exposición crónica** a situaciones adversas, del ambiente o de la organización. Es importante porque sirve para ampliar las enfermedades profesionales reconocidas.
- Las que no están en el cuadro pueden declararse **accidente de trabajo** si se prueba que su causa es **exclusivamente** el trabajo.
- Para los daños no físicos y el bienestar: **ergonomía** (adecuar el trabajo a la persona), **psicosociología** (factores psicosociales y organizativos) y **medicina del trabajo**.

🧯 Fallos en el control

pág. 18–20

🔑 Clave

La mayoría de accidentes e incidentes **no** los causan «trabajadores descuidados», sino **fallos en el control**, que son **responsabilidad de la dirección**. Rara vez son aleatorios y suelen tener varias causas.

🏢 Organizativos

Los que **más influyen** en el comportamiento, y los que más se olvidan al investigar. Hace falta una **cultura de seguridad**.

🧰 De la tarea

Diseño **ergonómico**. Los desajustes entre exigencias y capacidades aumentan el error. Ajuste **físico** (lugar y ambiente) y **mental** (información, decisiones, percepción).

🙋 Personales

Atributos **físicos** (fuerza, limitaciones) y **mentales** (hábitos, actitudes, habilidades, personalidad). Habilidades y actitudes se mejoran con formación; la personalidad casi no cambia: hay que **seleccionar bien**.

Resumen de la Unidad Didáctica 9 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.